SDD 292 Sujet n°1

Spécialité : psychiatrie

Date : 11/11/2024
Auteur : Pigeon Maurine (DES Psychiatrie Paris, EN 2024)
Relecteur(s) : Lucie-Lou VIAL (DES MAR Toulouse, EN 2024), Andres ESQUIVEL (DES Psychiatrie Paris, EN 2024), Julie NEJAR (Assistante Spécialiste, APHP), Yann LE STRAT (PUPH, APHP)

Domaine d'apprentissage principal	Entretien/interrogatoire
Domaine d'apprentissage secondaire	Stratégie pertinente de la prise en charge
Item(s) en lien avec la station	76 – addiction à l'alcool
Situation(s) de départ en lien avec la station	292 - première consultation d'addictologie
Matériel nécessaire à la station	Une table, deux chaises, une feuille de brouillon, un stylo
Contexte de la station	1ère consultation d'addictologie chez patient avec trouble de l'usage de l'alcool.

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes interne en médecine.
Vous recevez M. V, âgé de 45 ans en consultation pour la première fois dans un contexte de trouble de l'usage de l'alcool.

Consignes :
Vous devez réaliser en 7 minutes :

- Un interrogatoire ciblé
- Orienter le patient pour la suite de sa prise en charge addictologique en justifiant.

Vous ne devez pas :

- Examiner le patient.
- Proposer une thérapie (médicamenteuse ou non)
- Evaluer ou renforcer sa motivation éventuelle au changement

Attention : Vous avez 7 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (max 15 items)			
1.	Interroge la quantité d'alcool consommé ET interroge sur la fréquence de consommation	1 pt	☐
2.	Recherche des épisodes de « binge drinking » (boire plus de 6 verres lors d'une occasion particulière)	1 pt	☐
3.	Recherche des antécédents psychiatriques	1 pt	☐
4.	Recherche une consommation d'autres substances au moins 2 cités dont le tabac	1 pt	☐
5.	Recherche des idées suicidaires	1 pt	☐
6.	Recherche une tolérance (nécessité d'augmenter la quantité pour ressentir les effets)	1 pt	☐
7.	Recherche des tentatives de sevrage	1 pt	☐
8.	Recherche un retentissement dans la vie du patient (au moins 1 : sociale, professionnelle, loisirs…)	1 pt	☐
9.	Recherche des conséquences judiciaires ou financières	1 pt	☐
10.	Évoque une nécessité d'hospitalisation pour le sevrage	1 pt	☐
11.	Justifie car antécédent de sevrage compliqué ET polyaddiction	1 pt	☐
12.	Explique au patient qu'il ne doit pas arrêter de consommer brutalement par lui-même	1 pt	☐

Communications et attitudes

1. APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

2. APTITUDE À QUESTIONNER

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

4. APTITUDE À STRUCTURER/ MENER L'ENTREVUE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée

5. COMMUNICATION NON VERBALE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Se comporte de manière inappropriée (p. ex. ne regarde pas son interlocuteur, se comporte de manière offensante ou agressante) ou porte des jugements	Tente d'établir un contact visuel. Présente les difficultés à établir la conversation (p.ex. priorise l'accomplissement de la tâche clinique) et cela peut induire la frustration du patient/pair	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Établit la conversation	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Est attentif aux indices du patient/pair et réagit de manière appropriée par son comportement/gestes.	Montre une bonne maîtrise de ses comportements et cherche à les adapter afin de favoriser la conversation /établir une relation.

TOTAL	/16 points

Éléments de rétroaction :

ECOS reprenant les bases de l'addictologie :

- *1 et 2 : questionnaire AUDIT-C*
- *3 et 4 : antécédents*
- *5 : obligatoire en psy (demandez le tout le temps)*
- *6 à 8 : définition d'une addiction*
- *9 et 12 : sevrages précédents compliqués + polyaddiction dont benzos => hospitalisation*

ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds-« je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Contexte :
Vous êtes interne en médecine.
Vous recevez M. V, âgé de 35 ans en consultation pour la première fois dans un contexte de trouble de l'usage de l'alcool.

Consignes :
Vous devez réaliser en 7 minutes :

- Un interrogatoire ciblé
- Orienter le patient pour la suite de sa prise en charge addictologique

Vous ne devez pas :

- Examiner le patient.
- Proposer une thérapie (médicamenteuse ou non)
- Evaluer ou renforcer sa motivation éventuelle au changement
-

Plan de la station ECOS :

Le patient se trouve assis devant une table, l'étudiant s'assiéra en face de lui.

Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :

Bonjour docteur, un ami m'a conseillé de venir vous voir pour essayer de régler mon problème d'alcool.

Identité du patient :

Mr V. François, 35 ans, 70kg pour 1.75m

Mode de vie :

-étude/travail : A le bac. Sans emploi depuis 2 ans, s'est fait virer de son ancien travail de caissier car est n'est pas venu plusieurs fois à causes de soirées trop arrosées. N'a pas eu de problèmes avec la justice à cause de ses consommations, n'a pas non plus de dettes mais dépense tout son argent pour acheter de l'alcool.

-statut : Célibataire sans enfant. Vit chez des amis qui l'héberge. Plus de contact avec sa famille depuis 2 ans, se sont disputés à cause de l'alcool et la perte de son travail.

-loisirs : Ancien joueur de football amateur, ne va plus aux entrainements depuis quelques temps car il préfère rester chez ses amis boire des bières.

-Consommation :

- OH : 2 bières le midi, 5 l'après-midi et 2 shots de vodka le soir pour dormir. Boit depuis maintenant 5 ans. Sort plusieurs fois par semaine au bar avec ses amis ou il boit environ 10/12 bières.
  A dû augmenter les doses pour ressentir les effets.

- tabac : 5 cigarettes par jour

- prend 4 valium 10mg le soir depuis 1 an (prescrit pour une tentative de sevrage puis maintenant)

- Sevrage :
A déjà tenté 3 sevrages par lui-même, durée maximum d'arrêt de 1 mois, lors de la dernière tentative il y a 1 mois, il aurait eu des hallucinations et de violents tremblements. Il a eu peur et aurait alors reconsommé dès l'apparition des effets. N'a jamais vu de psychiatre/addictologue, seulement son médecin généraliste.

Comportement global :

Patient en demande d'aide, calme.
A peur des complications du sevrage, accepte volontiers l'hospitalisation si proposée par l'étudiant car cela le rassure.
Compliant aux soins.

Antécédents personnels :

Aucun

Antécédents familiaux :

Aucun

Médicaments :

DIAZÉPAM 10mg x4 le soir hors prescription.

Symptômes positifs :

Forte envie de consommer de l'alcool.
A l'impression de perdre le contrôle.
Affecté parcette situation mais pas de symptome dépressif, n'a pas d'idées suicidaires.
Sensation de troubles de la concentration.
Tremblements lorsqu'il est en manque.
Lors du sevrage il y a un an : violents tremblement, a vu des souris dans son lit.

Constantes :

FC : 76 bpm ; PA : 134/74 mmHg ; FR : 12 ; SpO2 = 98% ; T°= 36.5°C

Donnée complémentaire :

Aucune

Questions de relance :

Si à 6min30 l'étudiant n'a pas évoqué une prise en charge, demander :
« Du coup, comment ça va se passer le sevrage je dois revenir vous voir ? »

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

Plan de la station ECOS :

Une table, deux chaises, l'étudiant est assis en face du patient

Matériel nécessaire à la station :

-une table, deux chaises

-feuilles de brouillon

Documents présents dans la station :

- Feuilles d'évaluation de papier de secours